

Kit Trauma Moto

Manuel d'urgence — du plus au moins prioritaire

APPELER LE 144 EN PREMIER

TOUJOURS EN PREMIER

Enfiler les gants stériles. Ouvrir le sachet. Enfiler la main dominante en premier. Ne pas toucher l'extérieur des gants.

#1 PRIORITÉ ABSOLUE — risque de mort en minutes

HÉMORRAGIE MEMBRE Garrot Tourniquet RhinoRescue — bras ou jambe qui saigne abondamment

Matériel / Equipment : Tourniquet RhinoRescue + Marqueur

1 Déplier le garrot complètement.

Tirer sur les deux extrémités.

2 Passer autour du membre, 5–7 cm au-dessus de la plaie.

Jamais sur une articulation. Si plaie très haute : poser le plus haut possible.

3 Passer la sangle dans la boucle. Serrer fort. Fermer le velcro.

Plus de doigt possible sous la sangle = serrage correct.

4 Tourner la baguette windlass jusqu'à arrêt du saignement.

Continuer à tourner même si résistance.

5 Bloquer la baguette dans le clip. Fixer le velcro de sécurité.

Sans clip, la baguette peut se desserrer.

6 Écrire l'heure de pose sur la peau au marqueur.

Exemple : 'TQ 14h32'. Indispensable pour les secours.

■ Ne jamais retirer ni desserrer. **TIMER 20 MIN** : après 20 minutes de pose, relâcher légèrement 1–2 min pour laisser circuler le sang, puis resserrer. Au-delà sans relâchement = risque de perte du membre.

→ Saignement persiste : serrer encore, ou poser un 2e garrot juste au-dessus.

#2 PRIORITÉ HAUTE — saignement non garrotable

SAIGNEMENT NON GARROTABLE

Gauze + Bandage compressif — torse, épaule, aine, cou

Matériel / Equipment : Compressed Gauze RhinoRescue + Trauma Bandage Hartmann + Compresse + Ciseaux

1 Si vêtements gênent : couper avec les ciseaux à vêtements.

Dégager la plaie sans déplacer la victime.

2 Ouvrir la gauze. La garder compacte (format accordéon).

Le traitement hémostatique accélère la coagulation.

3 Localiser la source du saignement avec un doigt ganté.

Aller au fond — pas juste boucher l'entrée.

4 Enfoncer la gauze au contact de la source. Tasser fort, couche par couche.

Remplir entièrement la plaie.

5 Maintenir pression ferme à deux mains — 3 minutes sans lever les mains.

Regarder la montre. Le caillot se forme pendant ce temps.

6 Poser le bandage compressif Hartmann par-dessus. Tirer fort. Fixer.

Plaie superficielle : compresses Medicomp + pression directe à la main.

■ Ne pas retirer la gauze — le caillot partirait avec. Si ça transperce : rajouter des compresses par-dessus.

→ Plaie au cou : comprimer un seul côté. Ne jamais encercler le cou.

#3 PRIORITÉ HAUTE — plaie thoracique ouverte

PLAIE THORACIQUE Chest Seal — plaie pénétrante dans la poitrine

Matériel / Equipment : Chest Seal Vented RhinoRescue (x2 si possible) + Compresses

1 Reconnaître : sifflement à l'inspiration, sang mousseux, respiration difficile.

L'air entre dans la cavité pleurale — urgence vitale immédiate.

2 Couper les vêtements avec les ciseaux si nécessaire.

Exposer la plaie complètement.

3 Sécher la peau autour de la plaie avec une compresse.

Tamponner sans frotter. Zone de 5 cm autour.

4 Retirer le film protecteur du chest seal en tirant sur l'onglet.

Ne pas toucher la face adhésive.

5 Centrer sur la plaie. Appliquer du centre vers les bords. Appuyer 10 sec.

La valve doit être centrée sur la plaie.

6 Plaie de sortie dans le dos : poser le 2e chest seal identique.

Faire rouler la victime sur le côté pour accéder au dos.

■ Victime qui s'aggrave après pose : soulever un bord du chest seal 1–2 sec pour évacuer l'air, puis reposer.

→ La valve ventée s'auto-régule. Pas besoin d'intervenir dessus.

#4 PRIORITÉ MOYENNE — brûlure

BRÛLURE Burnshield — brûlure thermique ou chimique

Matériel / Equipment : Burnshield Sterile Trauma Hydrogel + Couverture de survie

1 Éloigner de la source. Retirer vêtements et bijoux si possible.

Sauf si collés à la peau — ne pas forcer.

2 Ne pas percer les cloques. Ne pas retirer la peau brûlée.

Les cloques protègent contre l'infection.

3 Ne pas refroidir à l'eau une grande surface brûlée.

Risque d'hypothermie. Utiliser directement le Burnshield.

4 Ouvrir le sachet. Retirer le film. Face gel vers la brûlure.

La face gel est brillante et humide.

5 Poser doucement sans appuyer. Ne pas frotter.

Effet apaisant quasi-immédiat.

6**Grande surface : envelopper dans la couverture de survie.**

Côté doré vers l'intérieur. Isoler aussi du sol froid.

■ **Jamais de crème, beurre, dentifrice, huile ou glace sur une brûlure.**

→ Burnshield efficace du 1er au 3e degré. Peut être réhumidifié à l'eau propre s'il sèche.

#5**GESTION DU CHOC — en attendant les secours****CHOC / ATTENTE****Couverture de survie — stabilisation en attendant le 144**

Matériel / Equipment : Couverture de survie aluminium + Bandage + Compresse

1**Reconnaître : pâleur, sueurs froides, confusion, pouls rapide et faible.**

Peut apparaître même si le saignement est stoppé.

2**Allonger sur le dos. Surélever les jambes de 15–20 cm.**

Pas si suspicion de blessure à la colonne vertébrale.

3**Envelopper dans la couverture — côté doré vers l'intérieur.**

Glisser aussi sous la victime si possible.

4**Parler. Rassurer. Surveiller la respiration.**

Sans conscience mais respire : PLS. Arrêt respiratoire : RCP.

■ **Ne rien donner à boire ni à manger.**

→ Couverture déployée au sol = signal visible de loin pour les secours hélitreuillés.

Motorcycle Trauma Kit

Emergency manual — ordered from highest to lowest priority

CALL 144 (CH) / 112 (EU) FIRST

ALWAYS FIRST

Put on sterile gloves. Open the packet. Put the dominant hand in first. Do not touch the outside of the gloves.

#1 ABSOLUTE PRIORITY — risk of death within minutes

LIMB HEMORRHAGE

RhinoRescue Tourniquet — arm or leg bleeding heavily

Matériel / Equipment : RhinoRescue Tourniquet + Permanent marker

- 1 Fully unfold the tourniquet.**
Pull both ends apart.
- 2 Place around the limb, 5–7 cm above the wound.**
Never on a joint. If wound is very high: place as high as possible.
- 3 Thread the strap through the buckle. Pull tight. Close the velcro.**
Cannot slide a finger under the strap = correct tightness.
- 4 Turn the windlass rod until bleeding stops.**
Keep turning even if resistance is felt.
- 5 Lock the rod in the clip. Secure the safety velcro.**
Without the clip, the rod can loosen.
- 6 Write the time of application on the skin with the marker.**
Example: 'TQ 2:32pm'. Essential information for paramedics.

■ **Never remove or loosen. 20 MIN TIMER: after 20 minutes, slightly release for 1–2 min to restore circulation, then retighten. Beyond 20 min without release = risk of limb loss.**

→ Bleeding continues: tighten further, or apply a 2nd tourniquet just above the first.

#2 HIGH PRIORITY — non-tourniquet bleeding

NON-TOURNIQUET BLEEDING

Gauze + Compression bandage — chest, shoulder, groin, neck

Matériel / Equipment : RhinoRescue Compressed Gauze + Hartmann Trauma Bandage + Gauze pads + Scissors

- 1 If clothing is in the way: cut with trauma shears.**
Expose the wound without moving the victim.
- 2 Open the gauze. Keep it compact (Z-fold format).**
The hemostatic agent accelerates clotting.
- 3 Locate the bleeding source with a gloved finger.**
Go deep — don't just cover the entry point.
- 4 Pack gauze firmly against the source, layer by layer.**
Fill the wound cavity completely.

5 Hold firm pressure with both hands for 3 minutes. Do not lift hands.

Watch the clock. The clot forms during this time.

6 Apply Hartmann trauma bandage on top. Pull tight. Secure.

Superficial wound: gauze pads + direct hand pressure.

■ Do not remove the gauze — the clot would come with it. If blood soaks through: add more gauze pads on top.

→ Neck wound: compress one side only. Never encircle the neck.

#3 HIGH PRIORITY — open chest wound

CHEST WOUND Chest Seal — penetrating chest wound

Matériel / Equipment : RhinoRescue Vented Chest Seal (x2 if possible) + Gauze pads

1 Recognise: sucking sound on inhale, frothy blood, difficulty breathing.

Air entering the pleural cavity — immediate life threat.

2 Cut clothing with scissors if needed.

Fully expose the wound.

3 Dry the skin around the wound with a gauze pad.

Pat don't rub. 5 cm radius around the wound.

4 Remove the chest seal film by pulling the tab.

Do not touch the adhesive side.

5 Centre over the wound. Apply from centre outward. Press for 10 sec.

The valve must be centred on the wound.

6 Exit wound in the back: apply the 2nd chest seal the same way.

Roll victim onto their side to access the back.

■ Victim deteriorates after application: lift one edge of the chest seal for 1–2 sec to release air, then reapply.

→ The vented valve self-regulates. No need to manually operate it.

#4 MEDIUM PRIORITY — burn injury

BURN Burnshield — thermal or chemical burn

Matériel / Equipment : Burnshield Sterile Trauma Hydrogel + Survival blanket

1 Move away from heat source. Remove clothing and jewellery if possible.

Unless stuck to the skin — do not force.

2 Do not burst blisters. Do not remove burnt skin.

Blisters protect against infection.

3 Do not cool a large burn with cold water.

Risk of hypothermia. Use Burnshield directly.

4 Open packet. Remove film. Gel side faces the burn.

The gel side is shiny and moist.

5 Apply gently without pressing. Do not rub.

Relief is almost immediate.

6

Large burn area: wrap in survival blanket.

Gold side facing inward. Also insulate from cold ground.

■ **Never apply cream, butter, toothpaste, oil or ice to a burn.**

→ Burnshield works on 1st to 3rd degree burns. Can be re-moistened with clean water if it dries.

#5

SHOCK MANAGEMENT — while waiting for EMS

SHOCK / WAITING

Survival blanket — stabilisation while waiting for paramedics

Matériel / Equipment : Aluminium survival blanket + Bandage + Gauze pads

1

Recognise: pallor, cold sweats, confusion, rapid weak pulse.

Can appear even after bleeding is controlled.

2

Lay victim on their back. Raise legs 15–20 cm.

Not if spinal injury is suspected.

3

Wrap in survival blanket — gold side facing inward.

Slide under the victim too if possible.

4

Talk. Reassure. Monitor breathing.

Unconscious but breathing: recovery position. No breathing: CPR.

■ **Do not give anything to eat or drink.**

→ Blanket spread on the ground = visible signal for air rescue.